

TEMA 1.33 • CARDIOLOGÍA

Enfermedades del Pericardio

PERFIL EUNACOM 1.01.1.022

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las enfermedades del pericardio comprenden un espectro que va desde la inflamación benigna autolimitada hasta emergencias médicas que comprometen la vida. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir la presentación clínica, los hallazgos electrocardiográficos y el manejo inicial de estas tres entidades: **Pericarditis Aguda**, **Pericarditis Constrictiva** y **Taponamiento Cardíaco**.

Pericarditis Aguda

Es la inflamación de las hojas pericárdicas, siendo un motivo frecuente de consulta por **Dolor Torácico**.

Etiología

En la gran mayoría de los casos (aprox. 90%) se clasifica como **idiopática o viral**. - **Virus comunes**: Enterovirus (Coxsackie), virus respiratorios (Influenza, Parainfluenza). - **Otras causas**: - Pericarditis urémica (secundaria a **Insuficiencia Renal Crónica**). - Bacteriana (rara, generalmente por neumococo desde una neumonía). - Post-infarto (Síndrome de Dressler).

Clínica

El diagnóstico es eminentemente clínico y se basa en: 1. **Dolor pleurítico**: Dolor retroesternal que aumenta con la inspiración profunda y la tos. 2. **Cambios posturales**: El dolor disminuye al inclinarse hacia adelante (**posición genupectoral**) y aumenta al estar en decúbito supino. 3. **Frote pericárdico**: Ruido superficial, áspero, que se escucha mejor con el paciente inclinado hacia adelante.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Hallazgo clave en el ECG: El supradesnivel del segmento ST en la pericarditis aguda es **difuso** (presente en casi todas las derivaciones), tiene concavidad superior (forma de "guirnalda" o "J") y puede asociarse a un **infradesnivel del segmento PR**.

Diagnóstico y Manejo

El diagnóstico se confirma con al menos 2 de los siguientes: clínica sugerente, frote pericárdico, cambios típicos en el ECG o derrame pericárdico nuevo en el ecocardiograma.

TABLA 1.33.1: PARÁMETRO VS HALLAZGO EN PERICARDITIS

PARÁMETRO	HALLAZGO EN PERICARDITIS
Electrocardiograma	Supradesnivel ST cóncavo difuso + Infradesnivel PR
Laboratorio	Elevación de PCR/VHS. Pedir Troponinas para descartar miocarditis.
Ecocardiograma	Útil para detectar derrame pericárdico asociado.

Tratamiento: 1. **AINES a dosis altas**: Ibuprofeno (600-800 mg cada 8 horas) o Indometacina. 2. **Colchicina**: Se añade para acelerar la resolución y, sobre todo, para **prevenir recurrencias**. 3. **Reposo deportivo**: Hasta la resolución de los síntomas y normalización de marcadores.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el paciente presenta elevación de troponinas, se habla de **miopericarditis**. Estos pacientes deben ser hospitalizados, ya que tienen mayor riesgo de arritmias y disfunción ventricular.

Pericarditis Constrictiva

Se produce cuando el pericardio inflamado se vuelve rígido, fibroso y, en ocasiones, calcificado, impidiendo el llenado diastólico del corazón.

Etiología

- Evolución crónica de una pericarditis aguda mal resuelta. - **Tuberculosis (TBC)**: Causa clásica y todavía vigente en ciertos contextos. - Enfermedades del tejido conectivo: **Lupus Eritematoso Sistémico** o Artritis Reumatoide. - Post-cirugía cardíaca o post-radioterapia.

Clínica

Se presenta fundamentalmente como una **Insuficiencia Cardíaca Derecha** aislada: - Astenia y adinamia. - Edema de extremidades inferiores, hepatomegalia y ascitis. - **Signo de Kussmaul**: Aumento paradójico de la presión venosa yugular durante la inspiración. - **Colapso "y" prominente**: En el pulso venoso yugular (descenso rápido de la presión al abrirse la válvula tricúspide).

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la constricción se basa en que el corazón está "atrapado" en una coraza rígida. Esto limita el llenado ventricular brusco, lo que genera las ondas de presión venosa características.

Diagnóstico y Tratamiento

- **Ecocardiograma**: Muestra un pericardio engrosado o calcificado y alteraciones en el flujo Doppler. - **Tratamiento**: - En fases iniciales (constricción transitoria): AINES y corticoides. - En fases crónicas/graves: **Pericardiectomía** (extirpación quirúrgica del pericardio). El pronóstico post-cirugía es excelente.

Taponamiento Cardíaco

Es una urgencia médica caracterizada por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico a una presión suficiente para comprometer el llenado cardíaco y el gasto cardíaco.

Etiología

- Complicación de una pericarditis aguda (derrame severo). - **Hemopericardio**: Por trauma torácico penetrante, rotura cardíaca post-IAM o disección aórtica. - Neoplasias (pulmón, mama, linfoma). - Uremia.

Clínica

Se caracteriza por la tríada de Beck (aunque no siempre está completa): 1. **Hipotensión arterial**. 2. **Ingurgitación yugular**. 3.

Ruidos cardíacos apagados.

Además, es característico el **pulso paradójico** (caída de la presión sistólica >10 mmHg durante la inspiración).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el ECG del taponamiento o derrame masivo se puede observar la **alternancia eléctrica**: los complejos QRS cambian de amplitud de un latido a otro porque el corazón "balancea" dentro del líquido.

Manejo de Urgencia

El diagnóstico es clínico y se confirma rápidamente con ecografía (Eco-FAST en trauma).

- **Pericardiocentesis de urgencia**: Punción subxifoidea para extraer líquido y descomprimir el corazón. Es una medida salvadora.
- **Tratamiento de la causa**: Si es traumático, suele requerir cirugía (toracotomía).
- **Ventana pericárdica**: En casos de derrames recurrentes o neoplásicos, se crea una comunicación quirúrgica entre el pericardio y el espacio pleural/peritoneal para evitar que el líquido se acumule a tensión.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un paciente con trauma torácico penetrante que presenta hipotensión e ingurgitación yugular, pero con pulmones bien ventilados (descartando neumotórax a tensión), el diagnóstico clínico es **Taponamiento Cardíaco** hasta demostrar lo contrario.

Resumen Comparativo

TABLA 1.33.2: CARACTERÍSTICA VS PERICARDITIS AGUDA			
CARACTERÍSTICA	PERICARDITIS AGUDA	P. CONSTRICTIVA	TAPONAMIENTO
Síntoma guía	Dolor pleurítico	Edema/Ascitis	Shock/Hipotensión
Hallazgo ECG	ST difuso / PR bajo	Inespecífico	Alternancia eléctrica
Signo Físico	Frote pericárdico	Signo de Kussmaul	Triada de Beck
Tratamiento	AINES + Colchicina	Pericardiectomía	Pericardiocentesis

Insuficiencia Cardíaca: Generalidades Fibrilación Auricular Síndrome Coronario Agudo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Hombre de 42 años con dolor pleurítico posicional que alivia al inclinarse adelante. ECG: ST cóncavo difuso e infradesnivel PR."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Pericarditis Aguda. Tratamiento: AINES a dosis alta + Colchicina 0.5 mg/día por 3 meses.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- La pericarditis viral/idiopática es la causa más frecuente en países desarrollados
 - El dolor pericárdico mejora sentado inclinado hacia adelante
 - ECG de pericarditis: elevación difusa del ST cóncavo con depresión del PR
 - Tratamiento: AINES + colchicina; colchicina reduce recurrencias
 - Triada de Beck del taponamiento: hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados
 - El pulso paradójico > 10 mmHg sugiere taponamiento cardíaco
 - El taponamiento requiere pericardiocentesis de urgencia
 - La pericarditis constrictiva tiene signo de Kussmaul y puede requerir pericardiectomía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES DEL PERICARDIO)

PREGUNTA 1

Hombre de 28 años consulta por dolor torácico agudo que empeora con la inspiración y en decúbito, y mejora al sentarse inclinado hacia adelante. Tiene fiebre de 38°C. ECG muestra elevación difusa del ST cóncavo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A) Aspirina + clopidogrel
- B) Ibuprofeno + colchicina
- C) Prednisona 1 mg/kg
- D) Pericardiocentesis diagnóstica
- E) Antibióticos empíricos endovenosos

PREGUNTA 2

Paciente hipotenso con ingurgitación yugular marcada y ruidos cardíacos apagados. El ECG muestra bajo voltaje y alternancia eléctrica. ¿Cuál es la conducta de urgencia?

- A) Diuréticos endovenosos
- B) Pericardiocentesis de urgencia
- C) Fibrinolíticos sistémicos
- D) Ventilación mecánica invasiva
- E) AINES a dosis altas

PREGUNTA 3

Paciente con antecedente de tuberculosis tratada hace 5 años presenta edema, ascitis e ingurgitación yugular que aumenta con la inspiración. TAC de tórax muestra calcificación pericárdica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Pericarditis aguda recurrente
- B) Miocardiopatía restrictiva
- C) Pericarditis constrictiva
- D) Insuficiencia cardíaca derecha por cor pulmonale
- E) Síndrome nefrótico

RESUMEN: ENFERMEDADES DEL PERICARDIO

Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. La pericarditis aguda es la más frecuente y se presenta con dolor torácico que mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante, frote pericárdico y cambios electrocardiográficos difusos con elevación del ST cóncavo. La causa más frecuente en países desarrollados es viral o idiopática. El diagnóstico de pericarditis aguda requiere al menos 2 de 4 criterios: dolor torácico típico, frote pericárdico, cambios ECG característicos y derrame pericárdico nuevo. El taponamiento cardíaco es una emergencia con la tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, junto con pulso paradójico mayor de 10 mmHg. El ecocardiograma muestra colapso diastólico de cavidades derechas. El tratamiento de la pericarditis aguda es con AINEs (ibuprofeno o aspirina) más colchicina para reducir recurrencias. Los corticoides se reservan para contraindicación o fallo de AINEs. El taponamiento cardíaco requiere pericardiocentesis de urgencia. La pericarditis constrictiva puede requerir pericardiectomía quirúrgica. La pericarditis tuberculosa, frecuente en Chile, debe considerarse siempre en el diagnóstico diferencial.